Anamnesefragen

Was kann ich für Sie tun?
Was führt Sie zu uns?

Wo genau haben Sie diese Schmerzen?
Seit wann haben Sie diese Schmerzen?

Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus?
Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten?
Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen, z. B. Haben Sie sich am Kopf vertletz?

Sind die Schmerzen dauerhaft da, oder gehen sie wieder weg?
Wie lange dauert die Attacke?
Ist es das erste Mal, oder hatten Sie schon früher ähnliche Symptome?
Waren Sie deswegen schon einmal bei Ihrem Hausarzt?
Wurde Ihnen Untersuchung durchgeführt?
Sind die Schmerzen mit der Zeit schlimmer geworden?
Können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Sind die Schmerzen stechend oder dumpf?
Wie stark sind die Schmerzen?
Gibt es etwas, das die Schmerzen verstärkt, z. B. Bewegung, oder etwas, das sie lindert, z. B. Hinlegen?
Haben Sie etwas gegen die Schmerzen genommen?
Wie viel mg Ibuprofen haben Sie eingenommen?
Wer hat das Ihnen verschrieben?

Ist das erstemal oder hatten sie schon früher ahnliche Beschwerde?

Haben Sie Lahmungerscheinungen oder Sprachstörungen?

Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie Augenlidnsenkungen, Mundvinkelsenkung oder Sclukstörung haben?

Haben Sie Fieber?

Haben Sie Schwindel? Welche Art ist der Schwindel. Ist es so, wie im Karussel oder wie Bootfahren? Ist er dauerhaft da oder geht er wieder weg?

Haben Sie Bewustseinverloren?

Sind Sie lichtempfindlichkeit oder larmenpfindlichkeit?

Leinden Sie unter Sehstörung, Hörstörung? Haben Sie schwarze Flimmer-Flecken vor ihrem Augen bemerkt?

Haben sie Kribelsgefühl oder Taubheitsgefühl bemerkt?

Müssen Sie öfter zum Wasserlassen? Wie viel Urin haben Sie?

Haben Sie verstarkten Durst bemerkt? Wie viel Wasser trinken Sie taglich?

Haben Sie Schmerzen oder Brennen beim Wasserlassen?
Welche Farbe hat der Urin?
Gibt es Blut im Urin?

Wie ist Ihr Appetit?

Haben Sie in der letzten Zeit Gewicht agbenommen oder zugenohmen?

Haben Sie Juckreiz?

Haben Sie trockene Haut bemerkt?

Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie Azetongeruch im Mund haben?

Fühlen Sie sich müde?

Können Sie sich gut konzentrieren?

Haben Sie bemerkt, dass Ihre Wunde spater als sonst geheilt wurde?

Haben Sie Herzrazen?

Haben Sie Übelkeit oder Erbrechen?

Ist Ihr Blutzucker gut eingestellt? Haben Sie in letzter Zeit Ihren Blutzucker gemessen? Wann war das? Wie hoch war das?Haben sich Ihre Essgewohnheiten verändert? Ein Diät?

Nehmen Sie Ihre Medikamente regelmaßig oder haben Sie es manchmal vergessen?

Ist Ihr Blutdruck gut kontrolliert? Haben Sie in letzter Zeit Ihren Blutdruck gemessen? Wann war das? Wie hoch war das?

Gibt es andere Beschwerden, die gleichzeitig auftreten?

⇨ Ich habe einen Verdacht **auf Komplikationen durch Ihre Zuckerkrankheit und Ihren Bluthochdruck**. Aber das bleibt nur eine Vermutung, wir werden bei Ihnen mehrere Untersuchungen machen, um das zu bestätigen. Ich werde zunächst Ihren Körper untersuchen, dann werde ich Ihnen Blut abnehmen, um einige Werte zu überprüfen, und dann werden wir möglicherweise Ihre Zuckerkrankheit- und Blutdruckmedikamente anpassen. Wir werden Ihnen die richtige Behandlung geben, um Ihre Beschwerden zu lindern. Machen Sie sich keine Sorgen, Sie sind hier in guten Händen.
Haben Sie noch Fragen?

ARZT-ARZT GESPRACH

Guten Tag, Herr Oberarzt, Frau Oberärztin.
Mein Name ist Sümeyra Firat. Heute habe ich eine neue Patientin aufgenommen. Bevor ich meine Patientin vorstelle, möchte ich Ihnen noch etwas Wichtiges mitteilen:
Ich habe einen Anruf aus dem Labor erhalten. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Müller einen Kaliumwert von **2,6 mmol/L** hat. Dieser Wert ist **deutlich erniedrigt** und entspricht einer **Hypokaliämie**.

Jetzt berichte ich über den Fall meiner Patientin.
Es geht um Frau Silvia Hammers. Sie ist 63 Jahre alt, am 24.12.1957 geboren, 187 cm groß und wiegt 89,8 kg.

Sie stellt sich bei uns wegen seit drei Tagen bestehender Cephalgie im Temporalbereich vor. Laut Angaben der Patientin sind die Schmerzen langsam aufgetreten; sie gab keinen Auslöser an.

Sie berichtet, dass die Schmerzen nicht ausstrahlen und die Schmerzintensität morgens bei 6/10 und abends bei 8/10 liegt.

Nach Angaben der Patientin sind die Schmerzen klopfend, pulsierend und persistierend.
Die Schmerzen verschlimmern sich abends und bei der Arbeit wegen Stress. Sie hat Ibuprofen 600 mg eingenommen, jedoch ohne Besserung.

Sie erwähnt, dass sie seit längerer Zeit rezidivierende, beidseitige drückende Cephalgien hat. Sie war deswegen nicht beim Hausarzt.

Begleitend klagt sie über Nausea, seit gestern Photopsien, Vertigo, Tachykardie, starken Durst und Pollakisurie.

Vegetativ-anamnestisch ergaben sich Insomnie sowie Menopause vor 10 Jahren.

In der Vorerkrankungsanamnese erwähnte sie eine arterielle Hypertonie seit 5 Jahren, die nicht gut eingestellt ist. Die letzte Blutdruckmessung war heute Morgen: 180/90 mmHg.
Sie leidet an Diabetes mellitus Typ II seit 8 Jahren, der nicht gut kontrolliert ist. Seit 2 Wochen sind ihre Teststreifen ausgegangen, weshalb sie den Blutzucker nicht messen konnte. Die letzte Messung vor 2 Wochen war erhöht.

Sie gab an, dass bei ihr vor 10 Jahren eine Cholezystektomie durchgeführt wurde.

Bei der Medikamentenanamnese ergab sich die Einnahme von Metformin 850 mg (1-0-1), Ramipril 5 mg (1-0-0), Magnesium in unklarer Dosierung (1-0-0) sowie Ibuprofen bei Bedarf.
Die Allergieanamnese war unauffällig bis auf eine Penicillinallergie, die sich in Exanthem und Pruritus äußert.

Bei der Noxenanamnese erwähnte sie lediglich den Konsum von zwei Gläsern Wein oder Prosecco alle zwei Wochen.

Die Familienanamnese ergab Pneumokoniose beim Vater, Gonarthrose bei der Mutter sowie Myokardinfarkt bei der Schwester, an dem sie verstorben ist.

Sozialanamnestisch ist sie Betriebsbuchhalterin von Beruf, verheiratet, lebt mit ihrem Mann und hat zwei gesunde Töchter.

Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine **Stoffwechselentgleisung bei unkontrolliertem Diabetes mellitus und arterieller Hypertonie** hin.
Die Cephalgie, Vertigo, Photopsien, die Vorgeschichte mit aHT und DM Typ II, der hohe Blutdruck heute Morgen sowie der zuletzt erhöhte Blutzuckerwert und die fehlende Blutzuckerkontrolle seit 2 Wochen sprechen dafür.

Differentialdiagnostisch kommen Migräne und Spannungskopfschmerzen, TIA in Betracht.

Um die Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen, die Vitalparameter wie Blutdruck und Blutzucker überwachen und Blut für das Labor abnehmen.
Außerdem ist es wichtig, ein EKG zu schreiben, um Herzrhythmusstörungen auszuschließen.

Die körperliche Untersuchung ist wahrscheinlich unauffällig.

Im Labor würde ich ein großes Blutbild, BZ, HbA1c, Ketonkörper im Blut und Urin, BGA, Entzündungsparameter (CRP, BSG, ggf. PCT), Elektrolyte, Nierenwerte, Leberwerte, Lipidprofil und Urinstatus, Gerınnungsparameter (D-Dimer)bestimmen lassen.

Anschließend werde ich eine Langzeitblutdruckmessung sowie ein CT-Schädel durchführen und ein Konsil in der Abteilung für Endokrinologie und Neurologie anfordern.

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, empfehle ich folgende Therapie:
Die Patientin wird stationär aufgenommen.
Als Initialtherapie sollen eine Infusionstherapie (Flüssigkeitszufuhr und Elektrolytsubstitution) sowie eine symptomatische Behandlung erfolgen.
Die Medikamente wie Antihypertensivum und Antidiabetika sollen angepasst werden.
Eine Ernährungsumstellung und Lebensstilveränderungen werden empfohlen.

Reaktionen:
Was ist Staublunge? Warum ist er daran verstorben? – DM

Staublunge ist eine Berufskrankheit, und entwickelt sich durch das Einatmen von Staubpartikeln. Diese Erkrankung tritt besonders häufig im Bergbau und Bauwesen auf.

Leider entsteht ein bleibender Schaden in der Lunge.

Warum ist ein Freund von meinem Vater nicht gestorben? Warum mein Vater? - DM

Es gibt verschieden Risikofaktoren. Dies kann mit der Dauer der Exposition zusammenhängen.

DM

- **Patient/ Patientin Datum (Vorname, Name, Geb.-Datum)**

Name: Iris Weber
Alter: 55 Jahre (geb. am 12.12.1969)
Größe: 1,73 m
Gewicht: 80 kg

- **Aufnahmegrund/ Diagnose (stichwortartig)**

Hauptbeschwerde:

- Seit gestern Abend, plötzlich aufgetretenes beidseitiges Flimmern, ohne Sehminderung.
- Seit 3 Tagen langsam aufgetretene, beidseitige, bestehende, progrediente und klopfende Kopfschmerzen im Temporalbereich ohne Ausstrahlung.
- Die Schmerzintensität: 6-8/10 nach der NRS (6/10 morgens, 8/10 abends)
- Auslöser: keine
- Lindernde Faktoren: keine
- Verstärkende faktoren: Stress am Arbeitsplatz
- Ähnliche Beschwerden: rezidivierende, drückende Kopfschmerzen, 2-mal/M
- Begleitsymptome:
  - Nausea ohne Emesis seit 3 Tagen
  - Schwankschwindel seit 3 Tagen
  - Tachykardie seit 3 Tagen
  - Polydipsie
  - Polyurie

V/A:

Inappetenz
Müdigkeit
Stressbedingte Insomnie

Gyn:

Menopause seit 10 Jahren

V/E:

DM Typ 2 seit 8 J. (unkontrolliert, letzte Messung 150 mg/dl)
aHT seit 7 J. (unkontrolliert, letzte Messung 150/90 mmHg)
seit 10 Tagen keine Blutdruck- und Blutzuckermessung.
Kopfschmerzen seit 10J. (rezidivierend, drückend)

M:

Metformin 850 mg 1-0-1
Ramipril 5 mg 1-0-0
Magnesium, unklare Dosis 1-0-0-0
Ibuprofen 600 mg b.B.

Vor-op:

Cholezystektomie aufgrund von Gallensteinen vor 10 J., ohne Komplikationen

- **Allergien/ Unverträglichkeiten:**

Penicillin (Exanthem, Pruritus)

- **Genussmittel/ Drogen:**
- Nikotinkonsum: Nichtraucherin
- Alkoholkonsum: 2 Gl. Prosecco oder Wein alle 2 Wo.
- Drogenkonsum: wurde verneint.

- **Sozialanamnese:**
  Betriebsbuchhalterin
  verheiratet
  2 gesunde Töchter

- **Familienanamnese:**
  Vater: verst. mit dem 40. Lj. an Pneumokoniose.
  Mutter: 83 J., leidet an Gonarthrose.
  Geschwister: 4 (die 3. Schwester verstorben an MI mit dem 65. Lj)

- **Verdachtsdiagnose:**
  Hyperglykämische Stoffwechselentgleisung aufgrund DM

- **Differentialdiagnose**
  Hypertensive Krise
  Migräne

- **weitere Diagnostik**
- KU
- EKG
- Labor: großes BB - CRP - BSG - BZ - Leberwerte - Nierenwerte -HBA1C, Ketonkörper im Blut und Urin - BGA
- Urinstatus
- endokrinologisches Konsil
- Ggf. CCT

- **Therapievorschläge**
- Stationäre Aufnahme
- Überwachung von Vitalzeichen, Blutdruck und Blutzuckerwerten
- Überwachung von E-lyte (Elektrolytkontrolle)
- Flüssigkeitszufuhr und Elektrolytsubstitution (Infusionstherapie)
- Insulin-Dauerinfusion (Der Blutzucker muss langsam und vorsichtig gesenkt werden)
- Ggf.Azidose Korrigieren (Bikarbonat geben)
- Analgetikum
- Antiemetikum
- Antihypertensivum

    - = der Patient sitzt und bei tiefer Einatmung, palpieren wir eine Schmerzhafte Gallenblase unter den rechten Rippen. Der Patient kann nicht mehr Einatmen
- DS über OB und Epigastrium
- Abwehrspannung und Resistenz
- **Ikterus**
- Bei Komplikationen: Fieber, Abgeschlagenheit → Cholezystitis

Was ist Murphy-Zeichnen? Schmerzbedingter reflektorischer Abbruch der Inspiration während Abtasten

Welche Organe können durch Sono untersucht werden? Gallenblase, Pankreas, Gallenwege, Leber
Welche sonographischen Befunde erwarten Sie?
- Choledocholithiasis:
    - **Konkremente mit dorsalem Schallschatten** als Hyperechogen (Echoreich / hell auf Ultraschall)
    - **Dilatation des Gallengangs** (= Erweiterung)
    - Wandverdickung der Gallenblase bei längerer Blockade
- Akute Cholezystitis / Cholezystolithiasis:
    - **Wandverdickung** > 3 MM (postprandial > 5 MM)
    - Mehrschichtung/Dreischichtung der Wand, ggf. mit umgebender freier Flüssigkeit im Gallenblasenbett
    - Konkremente mit dorsalem Schallschatten
    - **Vergrößerung der Gallenblasse**

Normbereich des Bilirubins: gesamt < 1.1 mg/dl, direkt < 0.3 mg/dl

Was machen Sie in der Notaufnahme? Was ist spezifischer, Lipase oder Amylase? Lipase
Ist es möglich, sofort eine Cholezystektomie durchzuführen? Nein, es ist besser, die OP nur in symptomfreien Zeiten (im symptomlosen Zustand) durchzuführen, d.h. nach Behandlung und Abklingen einer Gallenkolik (um die Komplikationen wie Infektion zu vermeiden).
Welches Analgetikum? Dosierung? Komplikationen?
- Metamizol bis zu 1000 mg pro Einzeldosis alle 6-8 Stunden
- Pethidin 25 bis 150 mg, Maximum Tagesdosis 500mg.
- NW:
    - Pethidin: Nausea und Vomitus, Miktionsbeschwerden, Obstipation, Krampfanfall, Hypotonie,
    - Metamizol: leukopenie und Agranulozytose, Hypotonie und Schock, Hautreaktionen, Nephro- und Lebertoxizität, Asthmaanfall

Litholyse? **Medikamentöse Auflösung von Steinen**. Ursodeoxycholsäure (= UDCA)
Lithotripsie? Extrakorporale **Zertrümmerung** von Konkrementen durch **Stoßwellen**

Komplikationen von Lithotripsie? Pankreatitis, Hauptgallengang Verschluss
Was ist Chirurgisches Konsil? es ist eine **ärztliche Beratung** durch einen anderen Spezialisten

14. Unkontrollierte Diabetes Mellitus / aHT s. 121 / s.2 (Neue)

Arzt-Patient-Gespräch

-Name, Geburtsdatum, Gewicht, Größe

- Silvia Hammers
- 63 J.
- *24.12.1957
- 1,87 m
- 89,8 kg

- Hat sie in letzter Zeit den Blutzucker gemessen?
  - Ich habe seit mehreren Tagen meinen Blutzucker nicht gemessen, aufgrund eines Streifenmangels. Die Praxis ist seit 2 W. geschlossen. Vor 15 Tagen war es aber erhöht.
    - Blutzuckerkrankheit ist eine Krankheit, die durch Medikamente sehr gut kontrolliert werden kann, wenn der Patient regelmäßige Kontrollen durchführt. Wenn Ihnen die Streifen ausgehen, sollten Sie nicht warten, sondern können sie rezeptfrei in der Apotheke kaufen.
  - Könnten Sie mir bitte ein Blutzuckermessgerät verschreiben? (Warum ist die Praxis geschlossen?)
    - Ich kann das für Sie verschreiben, aber Sie müssen sich jetzt nach einem neuen Hausarzt umsehen. Ich kann Ihnen am Ende des Gesprächs einen empfehlen, wenn Sie möchten.

Ich verstehe, dass die Teststreifen ausgegangen sind. Aber es ist wirklich wichtig, dass Sie ihren Blutzucker regelmäßig kontrollieren, damit wir Probleme früh erkennen und Komplikationen vermeiden können.

- aHT seit 5 J. aber nimmt Medikamente seit 3 J. ein. Bluthochdruck
  - Gestern 150/80, heute Morgen 180/90:
    - Ein zu hoher Blutdruck kann sehr starke Kopfschmerzen verursachen.

Sich umschauen nach → bisyoprolol 2 coristum 2

-Vor-OPs

- Laparoskopische Cholezystektomie / CCE vor 10/17 J. (komplikationslos)
  - Mir wurde vor zehn Jahren die Gallenblase entfernt. Ich habe nicht einmal eine Narbe bekommen, sie sind durch meinen Nabel gegangen!
    - War es durch Bauchspiegelung? Haben Sie eine große oder pünktlichen Narbe?

-Medikation

- Metformin 850mg 1-0-1-0 p.o. Nehmen Sie es regelmäßig oder haben Sie es manchmal vergessen?
- Ramipril 5mg 1-0-0-0 p.o. (nimmt seit 3 Jahren ein)
- Magnesium unklare Dosis 1-0-0-0 p.o.
- Ibuprofen 600mg b.B. p.o.

-Allergien

- Penicillin (Exanthem und Pruritus): Amoxicilline (Rotfarbe und Juckreiz)

-Noxen

- Tabak: nicht Raucherin
- C2: 2 Gläser Prosecco / Wein, jede 2 Wochen gel.
- Drogen: kein
  - Sieht es so aus, als würde ich Drogen nehmen? Natürlich, Sie sehen nicht so aus. Aber es ist wichtig, weil Drogen Wechselwirkung und Nebenwirkung mit anderen Medikamenten haben können.

-Sozialanamnese

- Betriebsbuchhalterin (zufrieden, seit 30 J.)
- verheiratet, wohne mit Ehemann Lumbago
  - Mein Mann leidet an Hexenschuss, Er konnte deswegen in letzter Zeit nicht arbeiten. Was ist die Therapie dafür? (Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule)
    - Jede Krankheit ist anders. Ich rate Ihnen, ihm zu sagen, dass ~~sie~~ er ~~ihren~~ seinen Arzt aufsuchen soll, um eine Diagnose zu stellen und eine geeignete Behandlung zu erhalten /Physiotherapie

Sie und symptomatische Therapie erklären
- 2 Töchter: gesund
- Kein Sport
  - Es ist sehr wichtig, regelmäßig Sport zu treiben. Vielleicht können Sie zumindest versuchen, jeden Tag 1 Stunde zu Fuß zu gehen? Das wäre wirklich gut für Ihre Gesundheit

-Familienanamnese

- Vater (40 J.): t an Pneumokoniosis (Bergwerker): mein Vater ist vor langer Zeit gestorben. Was ist Staublunge? Warum ist er daran verstorben?

Staublunge ist eine Berufs-Krankheit, die durch das Einatmen von Staubpartikeln verursacht wird. Diese Partikel schädigen die Lungen und zu schweren Atemproblemen führen, was leider in einigen Fällen tödlich enden kann. – Warum ist ein Freund von meine Mann nicht gestorben? Warum mein Vater?

- Mutter (83 J.): Gonarthrose: Kniegelenksarthrose
- Geschwister: 4 (3. Schwester t vor einem Jahr an MI mit 65 LJ) ich habe 4 Schwestern und eine von ihnen ist letztes Jahr an einem Herzanfall gestorben. Den anderen sind gesund Gott sei Dank.

-Fragen

Es gibt verschiedene Risikofaktoren, Diss kann mit der Dauer der Exposition zusammenhängen

- Was habe ich Frau Dr.? Ich verstehe nicht, was mit mir los ist. Werde ich sterben?

- Ich habe einen Verdacht **auf Komplikationen durch Ihre Zuckerkrankheit und Ihren Bluthochdruck**.

Aber das bleibt nur eine Vermutung, wir werden bei Ihnen mehrere Untersuchungen machen, um das zu bestätigen. Ich werde zunächst Ihren Körper untersuchen, dann werde ich Ihnen Blut abnehmen, um einige Werte zu überprüfen, und dann werden wir möglicherweise Ihre Zuckerkrankheit- und Blutdruckmedikamente anpassen. – ilaç dozları ayarlanacak.

Wir werden Ihnen die richtige Behandlung geben, um Ihre Beschwerden zu lindern. Machen Sie sich keine Sorgen, Sie sind hier in guten Händen.

Haben Sie noch Fragen?

Arzt-Arzt-Gespräch

Guten Tag. Mein Name ist Masson. Ich arbeite seit kurzem als Assistenzärztin in der Ambulanz/Notaufnahme.

Es geht um **Frau Silvia Hammers, 63** Jahre alt, der in gutem AZ (Allgemeinzustand) und leicht adipösem EZ (Ernährungszustand) gekommen ist.

Sie beschreibt Ihre aktuellen Symptome wie folgt: seit 3 Tagen klopfende und pulsierende Cephalgie, die sind beidseitig in der Regio temporalis. Die Schmerzen sind persistierend und progredient. Jetzt 6 von 10 auf einer Schmerzskala morgens und 8 von 10 abends nach der Arbeit. Ibuprofen 600mg hat Ihr nicht geholfen.

Begleitend sind seit gestern Nausea, beidseitige Photopsie, Vertigo und Palpitationen.

Sie berichtet auch eine Polydipsie, schmerzbedingte Stress und Insomnie.

Ansonsten ist die vegetative Anamnese unauffällig.

Sie leidet seit 8 Jahren an Diabetes Mellitus Typ 2 und nimmt regelmäßig dagegen Metformin 850mg. Auch seit 5 Jahre an arterielle Hypertonie und nimmt Ramipril 5 mg.

Sie nimmt auch regelmäßig Magnesium ein und Ibuprofen 600mg bei Cephalgie.

Sie ist allergisch gegen Penicillin.

Das wäre zunächst dem Relevanten.

Aufgrund der Anamnese habe ich den Verdacht auf unkontrollierte arterielle Hypertonie und Diabetes Mellitus. An Differentialdiagnosen sind zu nennen, Migräne, Meningitis, Subarachnoidalblutung (SAB).

Als erstes werde ich eine körperliche Untersuchung durchführen; dann halte ich eine Laboruntersuchung mit Bestimmung: gr. BB, CRP, BSG, ggf. PCT, Gerinnungsparameter (PT und D-Dimer), Amylase, Lipase, Leber-Nierenwerte, E-lyte, BGA, Glukose und HbA1c. Auch ein Urinstatus.

Anschließend ist ein Ruhe-EKG durchgeführt werden (mit Sehnenreflex), um eine kardiale Ursache zu vermeiden, und eine cranial-CT, eine Ophthalmoskopie / Fundoskopie. Ggf. eine Liquorpunktion (= *Liquorentnahme*)

Weiterführend ist einen endokrinologische oder ggf. einen neurologische Konsil anzufordern.

Ich werde sie stationäre aufnahmen (wg. Hypertensiver Notfall).

Als Therapie schlage ich initial/symptomatisch Flüssigkeits und Elytsubstitution (Infusiontherapie), Analgetikum (Metamizol)
Bei gesicherter Verdachtsdiagnose empfehle ich als kausaltherapie die richtige Dosierung von Antihypertensivum bzw. Insulinotherapie.

Sind Sie mit meinem /diesem Vorgehen einverstanden?

-Fragen BMI wird berechnet, indem man das Körpergewicht in kg durch die Körpergröße im Meter zur Quadrat teilt.

Ist sie übergewichtig? Wie kann man BMI ausrechnen? Körpergewicht dividiert durch Körpergröße hoch 2 (Quadrat der Körpergröße)

Was hat die Pat. vor 4 Tagen gemacht? Geburtstag, Kuchen gebacken und gegessen

Ursachen von starken Kopfschmerzen:

Welche Dosierung von Ibuprofen hat sie eingenommen? Warum fragen Sie danach? Ohne Rezept? 400 mg

Wo hat die Pat. Ibuprofen bekommen? Warum von dem Mann? Kann man Ibu 600 ohne Rezept kaufen? Nein

Hat sie Photopsie in beiden Augen? Wenn in einem Auge? Glaukomanfall

Misst die Pat. regelmäßig RR? Das letzte Mal?

Wie kann man den RR messen? Blutdruckmessgerät beim Arzt, die Selbstmessung zu Hause.

Multidetector computer tomographie →

(über Mdct) Ist das die richtige Methode? Nein, weil der Blutdruck hoher ist.

(6)

Was ist die max. Dosis von Ibuprofen? Pro Tag 2400 mg

Pneumokoniose: PPh, welche Stoffe? Silikose, Asbeztose

= Einatmung von anorganischen Stäuben. Typen von Pneumokoniose:

- Silikose: Quarzstaub
- Talkose: Talkum
- Berylliose: Berylliumstaub
- Siedrose: Eisenstaub
- Aluminose: Aluminiumstaub
- Antgrakose: Kohlenstaub
- Asbestose: Asbest
- Chalikose: Kalkstaub
- Byssinose: Baumwoll- Hanf- oder Flachsstaub

Kohlebegwerk - Kömür Occig!

Sommer
Wärmere Luft erleichtert die Atmung, die Beschwerden können leichter sein.
✓ Bei Hitze kann aber auch Belastungsdyspnoe auftreten

Winter
✓ Kalter Luft verschlechtert die Atemwege, → er bekommt mehr Dyspnoe
✓ Infektionen (Bronchitis/Pneumonie) treten häufiger auf.
✓ Insgesamt geht es ihm schlechter

Wie heißt medizinische Pneumokoniose? Staublunge

Warum hat der V. Pneumokoniose?

Was würde mit dem Vater im Winter und Sommer passieren?

Mit COVID? Schwerverlaufend bis zum ARDS (Schocklunge, akutes Lungenversagen)

Unterschied zwischen Buchhandlung/Buchhaltung? Woher kommt das Wort "Buchhalter"?

Was bedeutet das? Buchhandlung → Geschäft, in dem man Buch kauft (Buchladen)
Buchhaltung → Abteilung, die finanzielle Daten erfasst und verwaltet (Sachbuch)

Wie ist der Lebensstil der Pat.? Adipositas? Gesundes Essen? Sport?

Buchhalter → demand, der Geschäftsbücher führt (Lektüre Kaufmann Hilfsbuch)

Was deutet auf unkontrollierte DM hin?

Warum passiert Polyurie bei DM? Wegen Glukosurie, BZ > 180

Urinbefund bei DM? Proteinurie, Albuminurie, Pyurie, Glukosuria ✓

Komplikationen von DM? →

Was ist Polyneuropathie? Symptome? Schädigung vieler peripherer Nerven gleichzeitig
DM, Alkoholabuses, B12 Mangel → Kribbeln, Brennen, Taubheitsgefühl, vermindertes Schmerz- und Temperaturempfinden, Muskelschwäche, Gangunsicherheit, Nachts starke Beschwerden

Wie untersuchen Sie sie? Mikrofilament Mundgeruch von DKA? Süßsauer/ nach Azeton riechender Atem
Monofilamentistörung Neuropathie

Was bedeutet hypertensive Krise?
Sehr starker Blutdruck anstieg ohne Organschädigung

Was kann noch starke Kopfschmerzen verursachen?

KU? (>180/120)

Labor? Hypercholesterinämie, Hypertriglyceridämie, HbA1c: 11.5%, BZ: 486 mg/dl

HbA1c: Über welchen Zeitraum? Warum 3 Monate? Halbwertzeit (?) HbA1c zeigt den durchschnittlichen Blutzucker der letzten ca 8-12 Wochen
weil Erythrozyten eine Lebensdauer von etwa 120 Tagen haben (zentral gerinnt ca 60 Tage)

Was ist LP? Warum machen Sie LP? →

Warum Schädel-CT? →

Wie kann man Blutdruck messen? →

Bei der körperlichen Untersuchung suche ich nach neurologischen Auffälligkeiten wie motorischen, sensorischen und sensiblen Störungen, Veränderungen der Reflexe sowie Mundgeruch.

Urin Befunde bei DM: Glukosurie, Albuminurie

Name und Mechanismus der Corona-Impfungen

- Pfizer, Moderna (BioNTech) → mRNA-Impfstoff → bringt mRNA in die Zelle, die Spike Protein produziert → Immunsystem bildet Antikörper
- Astrazenka: Vektorimpfstoff → Ein harmloses Adenovirus dient als Träger für die DNA des Spike-Proteins.

Corona:

Pathologie,

Röntgen,

Komplikationen (während, nach)

- Pneumonie
- Schocklunge

Das Spike Protein ist ein Oberflächenprotein des Coronavirus, das an den ACE 2-Rezeptor (menschlicher Zellen) bindet und dem Virus das Eindringen in die menschlichen Zellen ermöglicht.

Was bedeutet Quarantine? Woraus stammt das Wort? aus dem Wort Vierzig, als das befallene Schiffen mussten vierzig Tagen im Hafen bleiben

COPD + COVID

Einheit von Troponin? µg/L mikrogramm pro liter

einheit → birim

Wenn die Pat. nach Hause möchte, was machen Sie? Sie muss den gegen ärztlichen Rat unterschreiben und ich muss einen vorzeitigen Entlassungsbrief schreiben.

Was ist eine Tischlerei? Schreiner, sie bearbeiten Holz

Unterschied zwischen DM Typ 1 und Typ 2

Tab. 8.14 Differenzierung des Diabetes mellitus Typ 1 und 2.

	Diabetes mellitus Typ 1	Diabetes mellitus Typ 2
Pathophysiologie	autoimmune Langerhanszell-Zerstörung mit absolutem Insulinmangel	Insulinresistenz mit relativem Insulinmangel
Genetik	eineiige Zwillinge: 30–50 %	eineiige Zwillinge: 100 %
Manifestationsfaktoren	Virusinfekte	Adipositas
Alter bei Erstmanifestation	< 40 Jahre (meistens 15.-25. LJ)	> 40 Jahre
Physiognomie	schlanke Patienten	adipöse Patienten
Klinik	Erstmanifestation durch Hyperglykämie (Polyurie, Polydipsie, Gewichtsverlust)	Erstmanifestation häufig durch chronische Folgeerkrankungen (Makroand Mikroangiopathie) oder begleitendes metabolisches Syndrom
Insulin und C-Peptid	fehlend	anfangs ↑, später ↓
Therapie	Insulinsubstitution	Diät, Bewegung, orale Antidiabetika bei Erschöpfung der endogenen Insulinreserve: Insulin
Komaform	ketoazidotisches Koma	hyperosmolares Koma

Beim ketoazidotischen Koma kommt es durch absoluten Insulinmangel zur Ketonkörperbildung und metabolischen Azidose.
Beim hyperosmolares Koma fehlen Ketone weitgehend, dafür besteht eine ausgeprägte Hyperglykämie und Dehydratation (Commiolaut) mit hohen Osmolarität

Unterschied zwischen Glaukom und Katarakt?

Was ist eine Hexe?

Cadı Sie benimmt sich wie eine Hexe

Eine fliegende, zaubernde, böse oder magische Frauenfigur.

→ Therapiegarant

Was bedeutet Komplianz? Ist die Pat, kompliant?

Therapietreue des Patienten

Therapiegarant

RF für zerebrovaskuläre Ereignisse?

Warum passiert Polyurie bei DM?

Was bedeutet Hypertensive Krise? Mehr als 180/120 mmHg, keine Organschädigung

Ursache von Gonarthrose:

- Degenerativer Knorpelabbau
- Entzündungen
- Gelenkfehlstellung
- höheres Lebensalter und erhöhtes Körpergewicht sind zusätzliche

Risikofaktoren für die Entwicklung einer Gonarthrose: Adipositär, Überbelastung

Typen von Lungenkrebs:

- Kleinzelliges Bronchialkarzinom
- Nicht-kleinzelliges Bronchialkarzinom
  - Plattenepithelkarzinom
  - Adenokarzinom
  - großzelliges Karzinom

Was bedeutet Syndrom? Gruppe von Krankheitszeichen

Symptome von HWS-Syndrom

Komplikationen von DM:

- Makroangiopatische Veränderungen: KHK, pAVK, TIA, Apoplex
- Mikroangiopatische Veränderungen: Nephropathie, Neuropathie, Retinopathie

Was ist Polyneuropathie und die Symptome: Systemisch bedingte Schädigung von peripheren Nerven.

Parästhesien und Sensibilitätsstörung vor allem an den Extremitäten (Akroparästhesie). Des Weiteren können motorische Ausfälle auftreten, später auch eine Druckempfindlichkeit peripherer Nerven (z.B. Wadendruckschmerz) und trophische Störungen (Ernährungsstörung des Gewebes durch Schädigung vegetativer Nerven).

Warum <u>Schaufensterkrankheit</u>? Patienten mit pAVK ihre Gehbewegung häufig unterbrechen müssen, da es durch die Durchblutungstörungen zu Schmerzen in den Beinen kommt (Claudicatio intermittens) / wie um vor jedem Schaufenster eines Geschäfts anzuhalten.

Was ist eine SAB: eine arterielle Blutung in den Subarachnoidalraum

Unterschied zwischen SAB und Subduralblutung, patientensprache: →

Unterschied zwischen Hysterektomie und Total-OP? Total-OP = Hysterektomie + Adnexektomie (laparoskopischen oder transvaginalen Organentfernung)

Untersuchung von PNP? Elektromyographie, Elektroneurographie (Lumbalpunktion, Biopsie peripherer Nerven)

Mundgeruch beim diabetischer Ketoazidose: Azeton (süßsaur)

Notfall

Hypertensiver ~~Krise~~

= kritischen Anstieg des Blutdruckes auf Werte >180/120 mmHg mit gleichzeitigen Zeichen akuter hypertensiver Organschäden.

Mögliche Organschäden sind:

- Lungenödem
- akute Herzinsuffizienz
- Angina pectoris bzw. Akutes Koronarsyndrom
- Aortendissektion
- Hochdruckenzephalopathie
- intrakranielle Blutungen (Apoplex)
- retinale Blutungen

Therapie:

α1 Rezeptor Blocker → Gefäße weiten sich.

- Stationär aufnehmen
- Urapidil i.v. verabreicht ☐ zu beachten ist eine langsame Injektion, als Startdosierung gelten **25 mg**.

ist ein blutdrucksenkendes Medikament, das vor allem bei hypertensiven Krisen intravenös eingesetzt wird.

Diabetes Mellitus typ2

Bestimmung aus venösem Blutplasma	Diabetes mellitus	„Prädiabetes"	Gesund
Glucose in mg/dL (nüchtern)	≥126 (≥7,0 mmol/L)	100–125 (5,6–6,9 mmol/L) = **Abnorme Nüchternglucose**	<100 (<5,6 mmol/L)
HbA_{1c} in %	≥6,5 (≥48 mmol/mol Hb)	5,7–6,4 (39–47 mmol/mol Hb)	<5,7 (<39 mmol/mol Hb)
2-h-Wert des oGTT* in mg/dL	≥200 (≥11,1 mmol/L)	140–199 (7,8–11,0 mmol/L) = **Pathologische Glucosetoleranz**	<140 (<7,8 mmol/L)

* oGTT = **oraler Glucosetoleranztest**: Wird nicht in der klinischen Routine, sondern nur bei unklarer Diagnose angewendet. Kann aber auch zum Ausschluss einer gestörten Glucosetoleranz durchgeführt werden. Die Bestimmung des HbA_{1c}-Gehalts im Blut ist dafür ungeeignet, da dieser noch lange normal bleiben kann.

Vorgehen bei stark erhöhtem Blutzucker in der Notaufnahme

① Zuerst klären: DKA oder HHS
- BGA (pH, HCO_3^-)
- Ketonkörper Blut im Urin
- Elektrolyte, Kreatinin
- Osmolalität
- EKG (Kalium)

② Volumentherapie vor Insulin
Zuerst beginne ich mit einer raschen Volumentherapie mit NaCl 0,9 %
Ausgeprägte Dehydratation ausgleichen
Nierenperfusion verbessern

③ Danach Insulin i.v. (Perfusor)
z.B. 0,1 IE/kg/Stunde
Ziel: Blutzucker 50–70 mg/dl pro Stunde
zu schneller Abfall vermeiden → Gefahr von Hirnödem

④ Kalium engmaschige Kontrollen
<3,3 mmol/l: kein Insulin (zuerst Kalium)
3,3–5,0: Kaliumsubstitution
>5: Kontrolle

⑤ wenn BZ < 250 mg/dl
- Glukosehaltige Infusion (z.B. 5%) hinzufügen
- Insulin weiterlaufen lassen.

bei Azidose/Ketoacidose zuerst gut ist

DKA	HHS
Glukose ↑	CO_2 ↑ 7600 mg/dl
pH Azidose	Normalhaltig ↓
Keton +++	-Haltig
Dehydratation 0%	CO_2-Behalten
Bilanz gleiche CO_2	Kontrollen z.Z.

15. Akute Pyelonephritis s.131

Arzt-Patient-Gespräch

Patient/in

Ires Rokens
63J.
* 14.08.1962
1,71 m 91,3 kg

Hauptbeschwerde

- seit gestern Abend bestehende, plötzlich aufgetretene, beidseitige Photopsie
- seit 3 Tagen bestehende, langsam aufgetretene, persistierende, klopfende, pulsierende, beidseitige Kopfschmerzen im Temporalbereich ohne Ausstrahlung
- die Schmerzintensität: 6/10 auf der NRS
- verstärkende Faktoren: Abends
- lindernde Faktoren: Einnahme von Ibuprofen 600 mg
- ähnliche Beschwerde: seit 3 Jahren, rezidivierend

Begleitsymptome

- Polydipsi
- Polyurie
- Nykturie

vegetative Anamnese

- Dyssomnie
- Tachykardie

Vorerkrankungen

- aHT seit 5 Jahren (heute Morgen: 170-90, gestern Abend: 140-80)
- DM Typ II seit 8 Jahren (seit 20 Tagen nicht gemessen wurde)

Op:

- laparoskopische Cholezystektomie

Medikamente

- Ramipril 5 mg (1-0-0)
- Magnesium unklare Dosis (1-0-0)
- Metformin 850 mg (1-0-1)

Allergien/Unverträglichkeit Ibuprofen 600 mg b.B.

- Penicillin (Pruritus, Exanthem)

Genussmittel

Nikotinkonsum: ∅
Alkoholkonsum: 1 Glas Prosecco / Prosecco pro Woche
Drogenkonsum: ∅

Sozialanamnese

- Buchhalterin
- verheiratet
- lebt mit ihrem Mann zusammen
- 2 Töchter (eine Adipositas)

Familienanamnese

- Vater; verstorben an Bronchialkarzinom mit 40. Lj., Pneumokoniose
  Mutter: chronische Gelenkschmerzen / Gonarthrose
  Schwester: ~~[illegible]~~ verstorben an Myokardinfarkt mit 55. Lj.

Verdachtsdiagnose

Stoffwechselentgleisung bei unkontrolliertem DM und unkontrollierter aHT

Differentialdiagnose

- Migräne
- Spannungskopfschmerzen

weitere Diagnostik

- KU
- Vitalparameter, EKG
- Labor: BB, Entzündungsparameter, Nieren-Leberwerte, Elektrolytwerte, BZ, HbA1C, Keton im Blut/Urin, BGA, Urinstatus
- ggf. CT-Schädel
- endokrinologisches Konsil

Therapie

- stationäre Aufnahme
- Flüssigkeitszufuhr
- Elektrolytsubstitution
- ggf. Insulininfusion (Der Blutzucker muss langsam und vorsichtig gesenkt werden)
- Medikamentenumstellung (Antihypertensiva, Antidiabetika)
- Patientenschulungen (Gewichtsreduktion, regelmäßige Bewegung, regelmäßige Kontrolle des Blutzuckerspiegels und Blutdrucks)

Analgetikum, Antiemetikum

SAB – Subarachnoidalblutung

Blutung zwischen Gehirn und der äußeren Hirnhaut

plötzlicher, sehr starker Kopfschmerzen

oft lebensbedrohlich.

Subduralblutung

Blutung unter der harten Hirnhaut, aber außerhalb des Gehirngewebes.

Meist nach Sturz oder Kopftrauma

Symptome entwickeln sich langsamer, besonders bei älteren Menschen

Eine subdurale ~~Hematom~~ Blutung ist eine Blutung zwischen ~~Schädel~~ Hirn und ~~Hirnhaut~~, oft nach einem Sturz und sie kommt eher langsam

Covid19

Pathologie

SARS-CoV-2 befällt (Hauptmaß) vor allem die Lunge (Alveolen)

führt zu diffuser alveolärer Schädigung, Entzündung und gestörter Gasaustausch.

kann eine Hypokoagulabilität verursachen (Thrombosen Embolien)

Röntgenbefund

- Beidseitige, periphere Verschattungen (Bolgelenkdurchm. Opazitäten) → Dokumentation
- Milchglasartige Infiltrate (Ground-Glass Opacities)

CT ist sensitiver

Hoguntbestätigen
isigt dokumentation
ac oci gunni.
Pneumoni → helle weiße
Pneumothorax → zu viel Luft

Komplikationen

Akut

Covid Pneumonie
ARDS (Schocklunge)
Thrombosen / Lungenarterie
Myokarditis

Spätfolgen

Long-Covid
Müdigkeit, Dyspnoe, kognitive Störungen
Anhaltender Geschmacks- Geruchsverlust
Postvirale Myokarditis oder Lungenschäden

Quarantäne → Absonderung einer Person, um die Ausbreitung einer Infektion zu verhindern (Kontaktsperre)

Woraus stammt das Wort?

Kommt aus dem Italienischen quarantaggiorni = 40 Tage

Im Mittelalter mussten Schiffe 40 Tage warten, bevor sie anlegen durften → Seuchenprävention (Hafenkontrolle)
(Corto Coig) (Geni)

(Sumnotz)
Die MDCT ist schneller, liefert hochauflösende Bilder und eignet sich besonders für Notfälle, und komplexe Gefäßstellungen (Sumnotz Sonntag)
Sie verwendet mehrere Detektoren und ermöglicht präzise 3D-Rekonstruktionen

Komplikationen von DM

Mikroangiopathien → Retinopathie, Nephropathie, Neuropathie
Makroangiopathien → KHK, Schlaganfall, pAVK, Koronar Herzkrankheit
Akut → Hypoglykämie, diabetische Ketoazidose, hyperosmolares Koma
Weiter → Infektanfälligkeit, Wundheilungsstörungen, diabetischer Fuß

Monofilament Test

Dayu soybini digelendirmiz icin yapilir.
Ich würde einen Monofilament Test zur Prüfung der Sensibilität durchführen, indem ich das Filament (Cincciesnez bir lif) an mehreren Punkten der Fußsohle bis zur leichten Krümmung (eğrilik) aufsetze (yerleştirmiz) und prüfe, ob die Patienten die Berührung (dokunus) wahrnimmt, (algılamız)
Hangisinde bu 3 noktada test edilir
Großzehenzuppe (Bos parmak ucu)
Fußballen unter dem 1. Metatarsalknochen
Fußballen unter dem 5. Metatarsalknochen

Wie misst man den Blutdruck

Patient sitzt oder liegt
Manschette an Oberarm anlegen
Mit Blutdruckmessgerät (manuel oder automatisch) messen
Zwei Werte bestimmen: systolisch / diastolisch
Messung in Ruhe, am besten mehrfach wiederholen

Wie macht man eine Blutabnahme

Patient sitzt oder liegt
Arm mit Stauschlauch stauen
Punktionsstelle desinfizieren
Kanüle einführen
Blut in Röhrchen abnehmen
Stauschlauch lösen
Kanüle entfernen
Druck ausüben
Pflaster aufkleben

Wir machen ein CT-Schädel, um eine Blutung oder einen Schlaganfall auszuschließen.
Eine LP (Lumbalpunktion) führen wir durch, wenn wir an eine Meningitis oder Enzephalitis denken. Bei unbehandelten Diabetes besteht ein erhöhtes Infektionsrisiko.

Allergie – Unverträglichkeiten

Eine Unverträglichkeit ist keine Immunreaktion, sondern ein Stoffwechselproblem, während eine Allergie eine Fehlreaktion des Immunsystem ist.

HWI → Harnweginfektion
Hinterwandinfarkt

ÖGD – Ösophago-Gastro-Duodenoskopie
Obere Gastrointestinaltrakt → ÖGD Besuchen

Bolus → eine einmalige, schnell verabreichte Medikamenten oder Flüssigkeitsdosis

Bulbus → ein rundlich geformter Abschnitt eines Organs

Sepsis → eine lebensbedrohliche Organdysfunktion aufgrund einer fehlregulierten Immunreaktion auf eine Infektion

Retina – Netzhaut

Kurativ Therapie → Heilung der Erkrankung

Palliativ Therapiansatz → Linderung von Beschwerden und Verbesserung der Lebensqualität

Körpergewicht dividiert durch
Körpergröße hoch 2
(Quadrat der Körpergröße).

(2)

- ~~Frau Doktor ich habe hier in der Notaufnahme viel gewartet, wie kommt es, dass man so lange warten muss?~~ ✓ Das tut mir Leid, aber Sie sind in der Notaufnahme und leider hatten wir einen älteren Notfall und dieser musste zuerst behandelt werden. Jetzt können wir starten.

-Hauptbeschwerde

- Cephalgie: Kopfschmerzen
  - Seit 3 T.
  - Regio temporalis, bds: auf der Seite des Kopfes, in der Nähe der Ohren, aber auf beiden Seiten
  - Keine Ausstrahlung
  - Langsam einsetzend
  - Progredient: es wird mit der Zeit immer schlimmer
  - Klopfend, pulsierend: es ist wie ein Hammer, der immer wieder auf meinen Kopf schlägt
  - Persistierend: nein die Schmerzen sind dauerhaft da
  - 6/10 morgens, 8/10 abends
  - Verschlimmert abends und bei der Arbeit
  - Ibuprofen 600 mg nicht geholfen: ~~Ich habe Ibuprofen vom Rezept meines Mannes eingenommen.~~ ✓ Das kann gefährlich sein. Bitte Nehmen Sie keine ~~[illegible]~~ Medikamente ohne Arzt/Ärztin ein, weil es zu Nebenwirkungen führen kann.
    - Es ist nicht gesund, die Medikamente Ihres Mannes zu nutzen. Wenn das ein rezeptpflichtige Arzneimittel ist, das heißt dass, Medikamente bei manchen Menschen Nebenwirkungen haben können. Fragen Sie das nächste Mal einfach zu Ihrem Hausarzt.
  - **Früher**: rezidivierende drückende bds. KS/Mo.
- Nausea: mir ist übel
- Photopsie: hat 3 Mal nach Sehstörung gefragt: ~~woher kommen meine Sehstörungen?~~ Moment kann ich nicht Ihnen antworten, es kann durch verschieden Ursachen auftreten ✓ Bitte seien Sie geduldig.
  - Seit gestern: es ist, als würde ich schwarze Flecken vor meinen Augen sehen
  - Bds

Lichtblitze
Sitz Glaskörper

- Vertigo: ich fühle mich auch schwindelig
- Palpitationen: ich habe auch Herzklopfen manchmal

- Haben Sie: Lähmungserscheinung, Kribbeln, Taubheitsgefühl, Kopfverletzung?
- Fieber und Nackensteifigkeit?
- Seh-/Hörstörung?

-vegetative Symptomatik

- Haben Sie ein ständiges Durstgefühl?
- Gehen Sie häufiger auf die Toilette?
- Hat sich Ihr Appetit erhöht?

- Polydipsie +: ich trinke im Moment viel Wasser, vielleicht 3L am Tag. Ich habe immer Durst ✓
- Insomnie + wegen den Schmerzen: ich kann nicht gut schlaffen und ich bin sehr müde ✓
- Stress + wegen der Arbeit: ich bin sehr gestresst ✓
- In der Mitte des Gesprächs wird beunruhigt wegen der Schmerzen: Frau Dr. Ich habe wirklich große Schmerzen, ich kann es nicht mehr aushalten

-gyn

- Menopause vor 10 J.: Ich habe meine Periode seit 10 Jahren nicht mehr bekommen.
- Ich war vor 6 Monaten bei meiner Frauenärztin und alles war in Ordnung

-Vorerkrankungen

- DM Typ2 seit 8 J.: Zuckerkrankheit
  - Kontrolliert, HbA1c 6,3%
    - Haben sich Ihre Essgewohnheiten verändert? Ein Diät?